EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 77504
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-01-17 11:04:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: FRESIA DEL CARMEN NOVOA ESPINOZA			RUN	: 7.341.969-7
F.Nac	: 03-07-2022	Edad	: 1 AÑO, 6 MESES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-01-13	Fecha Egreso	: 2024-01-17 11:04:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

ITU
VEJIGA NEUROGENICA
DM CON MAL CONTROL METABÓLICO
ANEMIA CRONICA
IRC ETAPA III
HTA
ACV ANTIGUO
DEMENCIA
EPOC

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. N31.0-VEJIGA NEUROPATICA NO INHIBIDA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. E10-DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. D63-ANEMIA EN ENFERMEDADES CRONICAS CLASIFICADAS EN OTRA PRATE (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. N18.9-INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
7. F03-DEMENCIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
8. J44.9-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE FEMENINA CON ANTECEDENTES MÓRBIDOS VEJIGA NEUROGÉNICA, DM CON MAL CONTROL METABÓLICO, ANEMIA CRÓNICA, HTA, ACV ANTIGUO, DEMENCIA, ITU A REPETICIÓN, HOSPITALIZACIÓN RECIENTE 12-12-24.

ES TRAÍDA POR FAMILIAR POR PRESENTAR COMPROMISO DEL ESTADO GENERAL, ORINA HEMATURICA - SE REALIZA IRRIGACIÓN CONTINUA , TOMA EXAMENES: ORINA INFLAMATORIA , PCR 61, LEUCOCITOS 14600 HB 8.6 SE DECIDE HOSPITALIZAR PARA TTO ANTIBIÓTICO DE SEGUNDA LÍNEA POR CULTIVOS ANTERIORES CON IMIPENEM. COMPLETA 3 DIAS CON TTO ATB, CON UROCULTIVO NEGATIVO, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES DENTRO DE SU CONDICION. SE DECIDE ALTA VIA HODOM Y COMPLETAR 10 DIAS CON ERTAPENEM. SE SUGIERE REALIZAR UC AL MOMENTO DE TERMINAR TRATAMIENTO ANTBITIOTICO.

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO ASISTIDO
2. REGIMEN PARA DIABETICOS BAJO EN SODIO
3. INSULINA NPH 18 UDS AM-10 UDS PM SC
4. ERTAPENEM 1GR CADA 24 HORAS EV
5. PARACETAMOL 500MG 2 COMPRIMIDOS CADA 8 HORAS VO
6. PREGABALINA 75 MG DIA VO
7. ATORVASTATINA 20 MG DIA VO
8. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 COMPRIMIDO EN AYUNO
9. QUETIAPINA 25 MG NOCHE VO
10. BISOPROLOL COMPRIMIDO 2,5 MMG DIA VO
11. SERTRALINA COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 1/2 COMPRIMIDO DIA VO
12. SEGUIMIENTO CONTROL METABOLICO DIABTES POR SU CONSULTORIO DE ORIGEN
13. SUGIERO REALIZAR UC AL COMPLETAR TRATAMIENTO ANTIBIOTICO

CAMILA COLLAO ITURRA
MEDICO TRATANTE
19088566-6

JEFE SERVICIO